

PROMPTS_Jaou_Yasmine_CDC.md

Journal de prompts — Phase Conception (CdC)

Étudiante : Yasmine Jaou

Partie du CdC couverte : Limites, pertes d'information, architecture applicative & revue de cohérence

Projet : IMY-triFHIR — Sujet B (Rendez-vous / calendrier patient, format cible HL7 v2, FHIR R4 4.0.1)

Outil IA utilisé : Claude (Anthropic)

Étape 1 : Analyse des pertes d'information (Gap Analysis)

- **Prompt envoyé :**

*"Tu es architecte d'interopérabilité. Détaille les pertes d'information lors du passage de l'écosystème FHIR vers le message HL7 v2 **SIU^S12**."*

- **Réponse de l'IA :**

Le message HL7 v2 **SIU^S12** est un standard d'événement de planification administrative (*Scheduling*). Par conséquent, lors de la conversion :

- **Pertes cliniques** : Les ressources FHIR **QuestionnaireResponse** (détail des symptômes) et **DiagnosticReport** (valeur chiffrée du score HBI) sont totalement exclues du message HL7 v2.
- **Perte de contexte** : La raison médicale ayant motivé la prise de rendez-vous (détection d'une poussée de Crohn) n'est pas transmise au SIH legacy, sauf si elle est concaténée sous forme de texte brut dans le champ **NTE** (Notes).

Étape 2 : Limites fonctionnelles et techniques

- **Prompt envoyé :**

"Énumère les 4 limites principales et hypothèses simplificatrices retenues pour la version v1 du prototype."

- **Réponse de l'IA :**

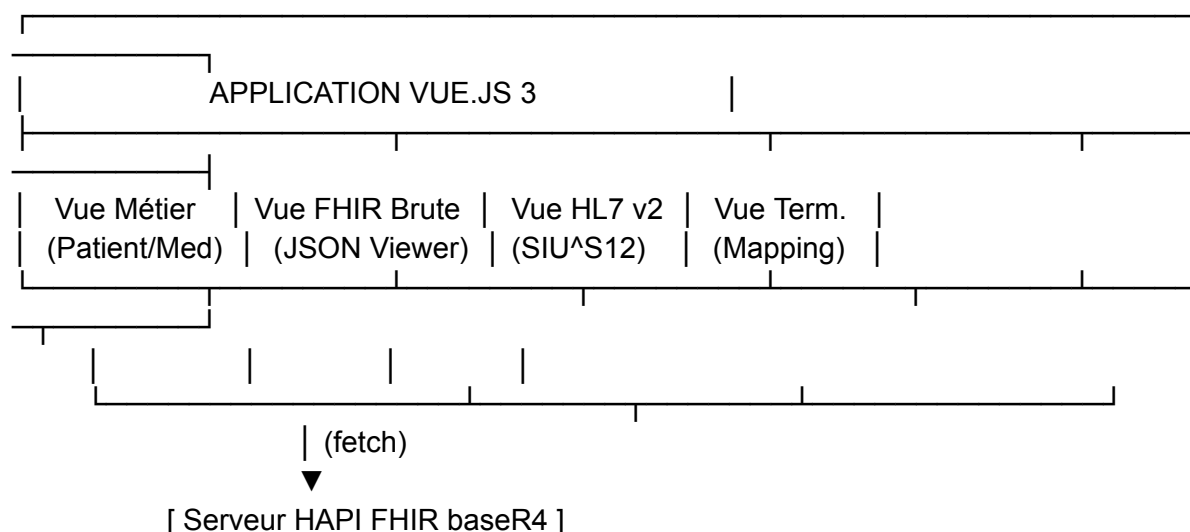
1. **Absence de récurrence** : Seuls les rendez-vous ponctuels sont pris en charge dans cette version.
2. **Terminologie HBI non standardisée** : Le score HBI est stocké en texte clair ou conclusion formelle sans codage LOINC/SNOMED CT dédié.
3. **Périmètre HL7 v2 restreint** : La conversion est à sens unique (FHIR $\rightarrow$ HL7 v2) et ne traite que l'événement de confirmation.
4. **Persistance volatile** : L'application repose intégralement sur l'état du serveur public sans base de données locale.

Étape 3 : Spécification des Vues applicatives Vue.js 3

- **Prompt envoyé :**

"Détaille l'organisation et la responsabilité des 4 vues front-end composant l'architecture de notre application."

- **Réponse de l'IA :**



1. **Vue Métier** : Offre l'interface utilisateur pour le remplissage du questionnaire, le calcul du score HBI et la validation/refus du créneau de consultation.
2. **Vue Ressources FHIR** : Affiche directement les structures JSON brutes échangées avec le serveur HAPI ([QuestionnaireResponse](#), [DiagnosticReport](#), [Appointment](#)).
3. **Vue Conversion HL7 v2** : Présente le message [SIU^S12](#) généré au format texte délimité par des pipes (|), prêt pour transmission.

4. **Vue Terminologies** : Présente le tableau de correspondance visuel entre les statuts FHIR (**proposed**, **booked**) et les codes de la table HL7 0278.

Étape 4 : Revue de cohérence globale

- **Prompt envoyé :**

"Effectue la revue de cohérence transversale entre l'analyse métier d'Inès, les contrats techniques de Meriam et l'architecture globale."

- **Réponse de l'IA :**
- **Alignement des statuts** : Le cycle de vie **proposed** $\rightarrow$ **booked** défini dans le besoin métier (Inès) correspond parfaitement aux endpoints **POST** et **PUT** spécifiés (Meriam) et à la logique d'affichage des vues (Yasmine).
- **Traçabilité des données** : La chaîne de conversion préserve la cohérence des identifiants patients depuis l'IHM jusqu'au segment **PID-3** du message HL7 v2.
- **Absence de contradiction** : Toutes les sections confirment le choix de l'architecture sans backend intermédiaire (*pure client-side Vue.js 3*).